TEMA 3 · Proceso enfermero. Derechos y deberes de los usuarios (Ley 3/2009) y Ley de Transparencia de Murcia

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: El proceso de atención de enfermería (PAE) · Bloque B: Ley 3/2009 de derechos y deberes y Ley 12/2014 de Transparencia

A1. Concepto, características y ventajas del PAE

- **Método sistemático** de trabajo que aplica el **método científico** al cuidado. Objetivo: cuidado **individualizado, integral y eficiente**.
- **5 fases** interrelacionadas y cíclicas: **Valoración → Diagnóstico → Planificación → Ejecución → Evaluación** (la evaluación retroalimenta una nueva valoración).

Característica	Significado
Sistemático	Orden lógico, evita omisiones e improvisaciones
Intencionado / planificado	Deliberado, con un fin y un plan previo
Holístico	Dimensión biológica, psicológica, social y espiritual
Dinámico y cíclico	Las fases se solapan y retroalimentan
Interactivo	Paciente y familia participan (sobre todo en objetivos)
Documentable	Queda en los registros: comunicación, continuidad, evaluación de calidad

- **Ventajas**: más calidad y seguridad, lenguaje común (**NANDA-I, NOC, NIC**), cuidado individualizado, carácter científico, continuidad de cuidados y datos para gestión e investigación.

A2. Valoración

- **Phaneuf**: proceso organizado y sistemático de búsqueda de información de diversas fuentes para conocer el grado de satisfacción de las necesidades, identificar problemas y recursos y planificar.
- Marcos de valoración: **14 necesidades de Henderson** y **11 patrones funcionales de Gordon**. NANDA-I recomienda los **patrones de Gordon** para la valoración inicial (y no los dominios de la taxonomía).
- **Validación de datos**: comprobar que están completos, que son exactos y consistentes, la congruencia entre datos subjetivos y objetivos, y distinguir el **dato observado de la inferencia**.
- Producto final: **perfil de salud** (problemas, riesgos, fortalezas, valores).

> **CLAVE PARA RECORDAR**
> - Patrones de Gordon (11): percepción-manejo de la salud, nutricional-metabólico, eliminación, actividad-ejercicio, sueño-descanso, cognitivo-perceptivo, autopercepción-autoconcepto, rol-relaciones, sexualidad-reproducción, afrontamiento-tolerancia al estrés y valores-creencias.

A3. Diagnóstico de enfermería

- **NANDA-I**: "juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad a un problema de salud real o potencial", que es la base de las intervenciones de las que la enfermera es responsable.
- Proceso: interpretar y agrupar datos, compararlos con las características definitorias, formular el enunciado.

Formato PES (Marjory Gordon)

Elemento	Qué es	Enlace
P – Problema	Etiqueta diagnóstica NANDA-I	—
E – Etiología	Factor relacionado (causa abordable)	"relacionado con" (r/c)
S – Signos/síntomas	Características definitorias	"manifestado por" (m/p)

Tipo de diagnóstico	Formato	Ejemplo
Real (focalizado en el problema)	**PES**	Dolor agudo r/c incisión quirúrgica m/p EVA 8/10
De riesgo	**PE** (sin síntomas)	Riesgo de infección r/c neutropenia
De promoción de la salud	**PS** (sin etiología)	Disposición para mejorar el autocontrol de la diabetes m/p deseo de aprender
Síndrome	**P** (+ factores propios)	Síndrome de desuso

- **NANDA-I 2024-2026**: **13 dominios, 47 clases y 277 diagnósticos**. Novedades: nueva clase en el Dominio 12 (Confort), revisión de los 8 ejes, términos MeSH, lenguaje inclusivo, nuevos diagnósticos (alfabetización en salud, envejecimiento saludable) y retirada de diagnósticos simples (obesidad, insomnio).
- **Priorización**: gravedad/urgencia, jerarquía de **Maslow** (fisiológicas primero) o **ABC** en emergencias. El riesgo alto va antes que los de bienestar.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **El diagnóstico de riesgo NO lleva "S" y el de promoción de la salud NO lleva "E".**
>
> ! NANDA-I aconseja valorar con los **patrones de Gordon**, no con sus propios dominios.

A4. Planificación

Dos componentes: **objetivos** (resultados esperados) e **intervenciones**. El sujeto del objetivo es **el paciente**.

Criterio SMART	Significa
S – Específico	Un solo resultado concreto, centrado en el paciente
M – Medible	Términos observables o cuantificables
A – Alcanzable	Posible según su situación
R – Relevante / realista	Coherente con el diagnóstico y consensuado con el paciente
T – Tiempo	Plazo definido (corto: horas-días; largo: semanas-meses)

- **Berman**: los objetivos describen, en respuesta observable del paciente, lo que la enfermera espera conseguir. Sirven para dirigir intervenciones, evaluar y motivar.
- **Carpenito**: objetivos **del paciente** → diagnósticos de enfermería; objetivos **de la enfermera** → **problemas de colaboración**.
- **Alfaro** (dominios): **afectivos** (actitudes: "aceptará la dieta"), **cognitivos** (conocimientos: "enumerará los síntomas de hipoglucemia") y **psicomotores** (habilidades: "demostrará la técnica de inyección").
- **NOC** (resultados): **7 dominios**, código de 4 dígitos (unos 540 resultados en la 6.ª edición; **612** en la 7.ª, de 2024). Indicadores con escala **Likert de 5 puntos**: **1 = peor estado** (gravemente comprometido), **5 = mejor estado**.
- **NIC** 8.ª ed. (2024): **614 intervenciones, 7 dominios, 30 clases**; 60 nuevas y 11 eliminadas.
- El plan se **registra**: diagnóstico, objetivos con plazo, intervenciones (qué, cómo, cuándo, frecuencia, quién) y evaluación.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! En la escala Likert NOC el **5 es siempre el estado deseable**, también en indicadores negativos como el dolor (5 = ninguno).

A5. Ejecución y evaluación

Ejecución

- Puesta en práctica del plan: **preparación** (confirmar que la intervención sigue siendo necesaria y segura), **explicación** al paciente, **aplicación**, **valoración de la respuesta** durante la actividad y **registro**.
- **Delegación (Alfaro-Lefevre)**: traspasar a alguien competente la autoridad para hacer una tarea concreta **manteniendo la responsabilidad de los resultados**.
- Registro: lo antes posible, solo hechos (sin juicios de valor), preciso, conciso, terminología aceptada y firmado.

Evaluación

- Continua (formativa) durante todo el proceso y formal al final del plazo.
- Se compara el estado actual con los resultados esperados (**indicadores NOC + Likert**): objetivo **alcanzado, parcialmente alcanzado o no alcanzado**. Si no se logra, se analizan las causas.

Decisión	Cuándo
Continuar	Objetivo parcial, el plan sigue siendo adecuado pero necesita más tiempo
Modificar	No alcanzado por un plan inadecuado o cambios del paciente
Finalizar	Objetivo conseguido, causa resuelta; también por alta, traslado o fallecimiento

TRAMPAS DE EXAMEN

! La enfermera **nunca delega la responsabilidad final** de los resultados.

! El PAE no acaba al evaluar: es cíclico y reinicia con una nueva valoración.

BLOQUE B · Ley 3/2009 de derechos y deberes y Ley 12/2014 de Transparencia

B1. Ley 3/2009, de 11 de mayo: principios y asistencia sanitaria

- Ley de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia. Fin: **humanización** de la asistencia, pública y privada.
- **Principios (Título I)**: universalidad, equidad, superación de desigualdades, integración y eficacia.
- **Humanización (art. 8)**: imperativo legal de confort físico y psicológico.
- **Tarjeta Sanitaria Individual (art. 11)**: personal e intransferible; incorpora **Braille de forma sistemática**.
- **Libre elección** de facultativo y centro (art. 12) y **segunda opinión** (art. 14) en procesos complejos o graves.
- **Acceso y demora máxima (art. 13)**: si se supera el plazo, el paciente puede elegir **otro centro de la Región**, con cargo al SMS.

Garantía de demora máxima (Decreto de 2006)	Plazo
Intervenciones quirúrgicas	**150 días**
Primeras consultas externas	**50 días**
Primeras pruebas diagnósticas	**30 días naturales**

Colectivos de especial protección

- **Embarazo, parto y puerperio (art. 15)**: parto natural con menos intervencionismo, analgesia epidural según indicación y demanda, lactancia materna y **acompañamiento ininterrumpido** por la persona que elija la mujer.
- **Menores (art. 16)**: acompañamiento de padres el máximo tiempo posible, continuidad educativa, evitar el ingreso si hay alternativas. Reforma por la **Ley 12/2018** (primeros 1.000 días): **contacto piel con piel inmediato e**

ininterrumpido e identificación inmediata del recién nacido. Las rutinas (peso, profilaxis ocular, vitamina K) se **posponen**.

- **Mayores, discapacidad y enfermos psíquicos (art. 17)**: eliminación de barreras.
- **Crónicos y terminales (arts. 18-19)**: tratamiento del dolor, **sedación paliativa** si está indicada, acompañamiento, apoyo psicológico y rechazo de la obstinación terapéutica.
- **Extranjeros (art. 20)**: atención sin discriminación según la legislación estatal.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Plazos **150 – 50 – 30** (cirugía – consulta – prueba). Las pruebas son **días naturales**, no hábiles.

! Recién nacido sano y estable: lo prioritario es el **piel con piel**; llevarlo a la cuna térmica para pesarlo es el distractor.

! El Braille en la TSI es **sistemático**, no "a demanda".

B2. Intimidad, confidencialidad e información

Intimidad (arts. 21-23)	Confidencialidad (arts. 24-28)
Esfera física: cuerpo, pudor, espacio	Esfera **informacional**: datos, historia clínica
Biombos, puertas cerradas, cubrir zonas, tono de voz	Secreto profesional, contraseñas, acceso restringido
Presencia de estudiantes: informar antes; el paciente puede negarse	Datos genéticos: **gratuidad**, prohibido comerciar
Derecho a acompañante y a asistencia religiosa	Excepciones: salud pública (EDO), mandato judicial o fiscal, daño grave a tercero

Información asistencial (Título IV)

- **Titular**: el **paciente** (fin del "pacto de silencio"). Información veraz, continuada y **comprensible**.
- Si el paciente es incapaz, se informa a familiares o representantes, pero también a él en la medida en que comprenda.
- **Derecho a no saber**: lo ejerce el **paciente**; se registra y cede si hay riesgo para terceros.
- **Necesidad terapéutica (privilegio terapéutico)**: la ejerce el **médico** si informar causaría un daño grave; se justifica por escrito en la historia y se informa a los allegados.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Términos de **cuerpo y espacio** = intimidad; **datos y registros** = confidencialidad.

! La familia pide ocultar el diagnóstico a un paciente capaz: **no se acepta**; el titular es el paciente.

B3. Autonomía de decisión y consentimiento informado (Título V)

- **Libertad de decisión (art. 41)**, incluido el **derecho a rechazar** un tratamiento.
- **Regla general: consentimiento verbal**. Por **escrito (art. 42.2)**: intervención quirúrgica, procedimientos **invasivos**, investigación o experimentación, riesgos de notoria repercusión negativa y, en embarazadas, actuaciones con riesgo para el feto.
- **Revocable por escrito en cualquier momento**, sin justificar.
- **Sin consentimiento (art. 45)**: riesgo grave para la salud pública o urgencia vital sin posibilidad de autorización.

Consentimiento por sustitución (art. 46)

Supuestos: incapacidad legal, incapacidad de hecho (a criterio del médico, registrada) y menor sin madurez.

Orden de prelación	Quién decide
1.º	Representante designado en las **instrucciones previas**
2.º	Representante legal (tutor o curador)

Orden de prelación	Quién decide
3.º	Cónyuge o pareja de hecho
4.º	Parientes más próximos (a igual grado, el de mayor edad)

Edad	Consentimiento
< 12 años	Por representación (padres o tutores)
12-16 años	Se le escucha; si es **maduro** decide él; si no, los padres
≥ 16 años o emancipado	**Mayoría de edad sanitaria**: decide él. En una actuación de **grave riesgo** para su vida o salud, consiente el **representante legal**, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del menor (Ley 41/2002 tras la Ley 26/2015)

Instrucciones previas (arts. 50-51)

Persona **mayor de edad, capaz y libre**; por escrito ante **notario** (sin testigos), ante **personal de la Administración** (Registro o unidades del SMS) o ante **3 testigos** mayores de edad y capaces, de los que **al menos 2** no tengan parentesco hasta el **2.º grado** ni relación patrimonial.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El consentimiento **no** es "siempre escrito": la regla es verbal.

! Ojo: el manual de este tema recoge la redacción antigua ("decide el menor y se informa a los padres"). La Ley 41/2002 vigente (reformada en 2015) dice que, en **grave riesgo**, consiente el **representante legal** tras oír al menor. Así lo recogen también los manuales de los temas 5 y 10.

! **Regla 3-2-2 de testigos. "Ninguno puede ser familiar" es falso: uno sí puede serlo.**

! En la sustitución, el familiar consanguíneo es el **último** escalón.

B4. Historia clínica y deberes (Títulos VI y VII)

- **Concepto (art. 52)**: conjunto de documentos de los procesos asistenciales. Finalidad principal: **asistencial**.
- **Requisitos (art. 53)**: legible, sin abreviaturas no reconocidas, **fechada y firmada**.
- **Conservación (art. 54)**: según el manual, **20 años desde el alta del último proceso** asistencial (la ley estatal exige un mínimo de 5). El expurgo lo valoran comisiones.
- **Acceso de profesionales (art. 55)**: solo para la asistencia del caso asignado. Curiosear historias es **falta muy grave** y puede ser delito. Para investigación o docencia, **datos anonimizados**.
- **Acceso del paciente (art. 56)**: tiene derecho a acceder y obtener copias, salvo los **datos de terceros** y las **anotaciones subjetivas** de los profesionales.
- **Fallecidos (art. 56.4)**: acceso de personas vinculadas por razones familiares o de hecho, salvo **prohibición expresa del fallecido**, datos de terceros o anotaciones subjetivas.
- **Deberes (arts. 61-63)**: respeto a profesionales (agresión = atentado contra la autoridad), datos veraces, cuidar las instalaciones, uso racional de servicios y cumplir citas.
- **Alta forzosa (art. 64)**: si el paciente rechaza el tratamiento y **no firma el alta voluntaria**, la dirección del centro, a propuesta del facultativo, dispone el **alta forzosa**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Excepciones al acceso del paciente: **terceros** y **anotaciones subjetivas**.

! **Los 20 años cuentan desde el último alta, no desde la creación del documento ni el nacimiento.**

! Doble negativa (tratamiento y alta voluntaria) = **alta forzosa**, no retención ni juez.

B5. Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana

- Modelo de **Gobierno Abierto**. No confundir **información clínica** (privada, Ley 3/2009) con **información pública** (contratos, presupuestos, listas de espera agregadas, Ley 12/2014).

- **Objeto (art. 1)**: transparencia de la actividad pública, derecho de acceso, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Concepto (art. 2)	Definición
Información pública	Contenidos y documentos en poder de la Administración, elaborados o adquiridos en sus funciones
Publicidad activa	La Administración **difunde por iniciativa propia** (retribuciones de altos cargos, listas de espera)
Derecho de acceso	El ciudadano **solicita** la información no publicada
Participación ciudadana	Intervenir en el diseño y evaluación de políticas
Gestión de documentos	Control sistemático de la creación a la conservación
Serie documental	Documentos de una **misma actividad administrativa**
Valoración	Fijar **plazos de conservación o eliminación**

- **Principios (art. 3)**: accesibilidad universal y **gratuidad** (consulta gratis; las copias o formatos especiales pueden tener tasas).
- **Portal de Transparencia** de la CARM y Consejo Regional de Participación Ciudadana.
- **Límites**: la protección de datos (LOPDGDD). Se concede **acceso parcial** anonimizando los datos de salud.
- Plazo de resolución: **20 días hábiles**, prorrogables otros 20. Sin respuesta: **silencio negativo**.
- No hace falta **motivar** la solicitud. Órgano garante: **Comisionado de la Transparencia** (unipersonal, 4 años), que sustituye al antiguo Consejo de la Transparencia.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La Administración publica sin que nadie lo pida = **publicidad activa**, no derecho de acceso.
! Silencio en una solicitud de acceso = **negativo** (desestimatorio).
! Transparencia: **20 días hábiles**. Demora de pruebas (Ley 3/2009): **30 días naturales**.
! Fechas: Ley 3/2009, de **11 de mayo**; Ley 12/2014, de **16 de diciembre**.